



# Amina 18

18-jährige Patientin, bisexuell, bosnischer Herkunft, aus einem engen bis sehr symbiotischen Familiensystem. Sie hat eine eineiige Zwillingschwester sowie eine jüngere Schwester und besucht die Oberstufe der FOS. In der Familie herrscht ein enger und repressiver Erziehungsstil mit wenig Freiraum für eigene Entscheidungen. Beziehungen zu Personen anderer Herkunft als aus Albanien, Kosovo oder Bosnien werden von den Eltern nicht akzeptiert. Nach einmaligem Cannabiskonsum entwickelte die Patientin aufgrund der Angst vor der Reaktion ihrer Eltern starke Schuld- und Angstgefühle. In der Familienanamnese ist eine depressive Episode bei einer Verwandten bekannt.

Die Patientin beschreibt ein stark negatives Selbstbild und empfindet sich selbst als „hässlich“, „dick“ und „furchtbar“. Körperliche Vorerkrankungen bestehen in Form einer Hashimoto-Thyreoiditis (chronische Schilddrüsenerkrankung) sowie einer Hypertonie. Zu beachten ist die bekannte Korrelation zwischen endokrinologischen Erkrankungen und psychischen Störungen, insbesondere die mögliche Mitverursachung affektiver Störungen durch eine chronische Schilddrüsenunterfunktion.

Komorbid bestehen Panikattacken (F41.0), welche zu den neurotischen, Belastungs- und somatoformen Störungen der Gruppe F40–F48 gehören.

Diagnose: F32.1 (G) mittelgradige depressive Episode.

Symptome: anhaltende Niedergestimmtheit, verminderter Selbstwert, Antriebsverlust, Libidoverlust, massive Ein- und Durchschlafstörungen, rasche und wechselhafte Gewichtszu- und -abnahme, Leistungseinbruch in der Schule, häufige Gereiztheit, Aktivitätsverlust sowie innerer und äußerer Rückzug.